جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هدي احمد موسي ابوطالب
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الساحل **العنوان :** 0000
رقم البطاقة : 25809220103861 **رقم التليفون :** 01287001314 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 10-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 22-09-1958 **المهنة :** لاتعمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هدي احمد موسي ابوطالب
National ID: 25809220103861

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

الصحة والسكان
مراكز الطبية المتخصصة
شفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hoda Ahmed Mousa Abou-Taleb	Date : 03/12/2024
Age : 66 Year(s)	Patient ID: 43496
Exam : MRI LUMBER SPINE	43496

MRI EXAMINATION OF THE LUMBO-SACRAL SPINE

Technique of examination:

- Sagittal T1 & T2 WIs
- Axial T2 WIs

MRI Findings:

Known case of breast cancer

- Straightened lumbar curve with good alignment.
- Normal dimensions of the bony lumbar spinal canal.
- No lumbar vertebral structural collapse or marrow infiltrative lesions
- Subtle marginal lippings of lumbar vertebral end plates
- Degenerated lumbar discs evidenced by loss of bright T2 signal
- L4-5 mild posterior disc annulus relaxation is seen gently effacing the ventral epidural fat
- L5-S1 posterior disc bulge more inclined to the left is seen effacing the ventral epidural fat, indenting theral sac and mildly encroaching upon the left exit neural pathway
- Normal MRI appearance of the conus medullaris and cauda equine nerve roots.
- No gross facet joints arthropathy
- No paraspinal masses or collections.

Opinion:

Mild spondylodegenerative changes with L5-S1 posterior disc bulge more inclined to the left as described

Dr. Alaa Ragab Hani, MSc, FEBR
Dr. Ibrahim Abo El Magd, M.D.

M.R.I
[[DOCTYPE:MRI]]

Women's Health Outreach Program

Name: hoda ahmed mousa
Date: 20.12.2021

Contrast Enhanced Full field Digital Mammography

Clinical summary:
left breast pathologically proven IDC

Technique
Pre and post contrast MLO and CC views
Targeted High Resolution Ultrasound

Detailed Findings:

left breast:

- heterogeneously dense breasts (ACR c).
- minimal back ground enhancement
- **Contrast enhanced images showed:**. upper outer axillary tail posterior third rounded lesion showing moderate heterogeneous mass enhancement with ill defined margin, measuring about 2.3x1,2 cm in diameter , 9cm from the nipple. surgical metallic clip is noted within the lesion.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- mildly enlarged axillary nodes , max cortical thickness 3.3 mm.

right breast:

- heterogeneously dense breasts (ACR c).
- minimal back ground enhancement
- **Contrast enhanced images demonstrated:** no pathological contrast uptake
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Preserved axillary nodes .

Conclusion:
left breast: (BIRADS 6) upper outer unifocal malignant mass as described
right breast: (BIRADS 2) normal study.

Best regards,
Dr lamiaa adel , MD

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

PATHOLOGY UNIT

Age / Gender	63 Years - Female	Patient ID	0-494
Registered	2021-09-15 08:56:14	Patient Name	هدى احمد موسى ابوطالب
Reported	2021-09-19 10:00 ص		

Pathology Report

Specimen : Tru cut biopsy from left breast lesion (10 o'clock).

Gross :

Three tan colored tissue cores partially fragmented , ranging from 1 up to 3 cm , in length , totally submitted.

Microscopic :

Section examined reveals multiple cores infiltrated by cords and nests of malignant epithelial cells exhibiting moderate to marked nuclear anaplasia and poor attempts of tubular formation surrounded by desmoplastic stroma.
Ductal carcinoma in- situ is not detected in received specimen.

Diagnosis :

Left breast mass, core biopsy:
- Invasive duct carcinoma, NOS grade II/ III.
- Cone needle biopsy category B5.

Nourhan Zaraty

Signature
Prof. Dr. Neha Radwan.
Dr. Mariam Ibrahim.

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hoda Ahmed Mousa Abou-Taleb	Date : 30/10/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 65 Year(s)
Medical ID: 4813/2021	Pat. ID: 43496

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Left breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

Left breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Right Breast:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Signature Dr. Peter Nashat

30/10/2023 4:52 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Nasr El Islam hospital
Color duplex unit
Tel : 4328495 - 4328496

مستشفى نصر الإسلام العام
وحدة الدوبلر الملون وفحص الأوعية الدموية
ت : ٤٣٢٨٤٩٦ - ٤٣٢٨٤٩٥

Name: Hoda
Date: 2021-08-21

LEFT BREAST US revealed:

- A well-defined hypoechoic soft tissue lesion is seen in the left breast (at 2 O'clock) ,
- this lesion shows slightly wavy outer border and minimal areas of central degeneration ,
- this soft tissue lesion measures 17 X 12 X 18 mm,
- for further Left breast mammography and FNACytology correlation.
- *The rest of left breast parenchyma shows uniform texture with fatty predominance.*
- *Normal skin thickness of the left breast with normal nipple areolar complexes.*
- Left sided few axillary benign, non specific lymph nodes , all of them with preserved central fatty hilum.
- No suspicious enlarged lymph nodes were noted.

Dr. Mohammed Zakaria MSc.

العنوان : ميدان نصر الإسلام – شبرا مصر – البساتين
العمل جميع أيام الأسبوع